

09 - 09- Les Eczemas - Pr. Hocar

Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une autre dermatose prévigineuse, c'est les eczémas. C'est une dermatose qui est très fréquente. L'eczéma de contact est une cause majeure des eczémas.

Elle est due à une sensibilisation percutanée à des molécules non tolérées ou allergènes. L'eczéma atopique et l'eczéma de contact peuvent être associés, en particulier dans le cas de dermatite des mains. Les objectifs du cours des eczémas sont comme il suit.

D'abord, savoir les définir. Puis expliquer la physiopathologie et les formes cliniques de l'eczéma de contact. Et puis la physiopathologie et les formes cliniques de la dermatite atopique.

Planifier une démarche diagnostic-étiologique de l'eczéma de contact. Et bien sûr, identifier les complications de l'eczéma de contact et de la dermatite atopique. En dernier, il faut savoir connaître les principes thérapeutiques de l'eczéma de contact et de la dermatite atopique.

Les eczémas sont l'ensemble de dermatoses inflammatoires. Qui ont en commun une inflammation cutanée plurigineuse. Et qui ont un mécanisme physiopathologique et d'étiologie multiple.

Ce sont l'ensemble de symptômes qui vont associer un érythème, une visécure et un fluide. Et puis par la suite, ils passent par des stades différents d'évolution. Et ils ont en commun des aspects cliniques et des aspects histologiques.

Le diagnostic des eczémas de façon générale et de clinique. Et on va commencer par des formes. La forme typique d'ailleurs d'eczéma, c'est l'eczéma aiguë.

Il comprend plusieurs phases. Les lésions sont très plurigineuses. Il réalise des placards erythémateux à contour immité.

L'eczéma aiguë évolue en quatre phases successives, selon un triquet. La première phase, c'est la phase erythémateuse. Caractérisée par la présence de placards erythémateux, odémateux, mal limités.

Suivie par la phase vésiculeuse. Faites de vésicules remplies de liquide clair. Conflant parfois en bulles.

Puis la phase de sointement. Ou la phase sointante. Due à la rupture des vésicules spontanément ou après grattage.

Lorsqu'on éponge la lésion, on retrouve des petites exulcérations peptiformes. Ce qu'on appelle les pieds eczématiqués de l'hévergie. Et puis au final, on peut avoir la phase croûteuse.

Suivie d'une guérison sans cicatrice. Puisque les lésions sont superficielles dans l'épiderme. Ces deux photos montrent un eczéma aiguë.

On voit à gauche la phase erythémateuse et la phase vésiculeoduleuse. Et à droite, on a le début de la phase croûteuse. Et une phase disquamative avec les lésions liquidiennes à côté.

Encore deux photos qui vont montrer un eczéma d'éma. À la phase chronique. Ce sont des eczémas avec une phase disquamative et des lésions chroniques.

Là, ces photos montrent un eczéma aiguë. La phase erythémateuse, la phase de sointement. On a la phase de rupture de lésions liquidiennes.

Et là, ce qu'on appelle les lésions peptiformes de l'hévergie. Ce sont des lésions peptiformes érosives qui font suite à la rupture des vésicules. Là aussi, ces deux personnes présentent des eczémas.

Donc, notez que l'eczéma, selon la forme de contact, il traduit ou il dissime l'objet ou la substance qui a hérité la peau. Et donc, on peut avoir des aspects différents selon la cause ou selon l'étiologie de cet eczéma. Là, c'est un monsieur qui présente un eczéma par photosensibilité.

Regardez la distribution topographique des lésions, surtout au niveau des mains, des pieds, au niveau du visage. C'est des zones exposées au soleil. À côté de la forme aiguë de l'eczéma, on peut distinguer des formes chroniques, comme l'eczéma liquidifié.

Le grattage va entraîner un épississement de la peau qui devient quadrillée et pigmentée. On peut avoir aussi un eczéma chronique, surtout au niveau des pommes et des plantes. Dans cette localisation, les lésions sont fréquemment fissuraires et hyperkératosiques, entraînant une kératodermie et palmonclontère.

On peut avoir aussi des formes infectées, les soins de plantes deviennent louches, et des placards d'eczéma se recouvrent de produits onapres, ce qu'on appelle l'infectigisation, qui peut être traité à ce moment-là par antibiothérapie. Nous arrivons à l'étude histopathologique. On pratique la vie psychotannée habituellement inutile au diagnostic.

Elle n'est réalisée qu'en cas de doute diagnostic ou pour documenter le caractère spongiotique d'un test épicotané. L'examen histologique montre une spongiose. La spongiose définit un oedème dissociant les kératinocytes et aboutissant à la formation de vésicules intraépidermiques.

Et puis on a une exocytose, ce qui traduit un infiltré de cellules mononucléées entre les kératinocytes. Pour noter que ça, ces lésions histologiques, on les voit souvent dans la forme aiguë. Elles peuvent manquer dans les formes chroniques.

Sur le plan dermique, on peut avoir un oedème dermique qui traduit une inflammation avec un

infiltré riche. On l'applique aussi après l'immense périvasculaire. Pour un caractère didactique, on classifie les eczémas en eczémas d'origine exogène, ce sont les eczémas de contact, et puis en eczémas d'origine endogène.

Donc en premier, on a la dermatite atopique, il y a l'eczéma numulaire, la dyshidrose et les eczémas dyshidrosie, l'eczéma microbien et l'eczéma de Stein. Nous allons commencer par les eczémas de contact. L'eczéma de contact est la deuxième grande cause d'eczémas à côté de la dermatite atopique.

Il est dû à une sensibilisation par borbutanée à des petites molécules qu'on appelle aptènes présentes dans notre environnement, à l'opposé de la sensibilisation à des protéines qu'on appelle atopènes dans le cas de la dermatite atopique. Les eczémas de contact de cause professionnelle sont parmi les plus fréquents des maladies professionnelles. L'eczéma de contact et l'eczéma atopique peuvent s'associer, expliquant l'efficacité relative des mesures d'éviction, par exemple pour les dermatites des mains.

Certains allergènes n'induisent pas un eczéma de contact après irradiation par les rayons épraviolés, c'est le cas des photos allergies. La réalisation des tests épiputanés doit être orientée par l'interrogatoire et l'examen clinique. On peut rester sensibilisé très longtemps à un allergène de contact trauma.

La pertinence des tests épiputanés positifs doit donc systématiquement être discutée. Les allergènes les plus fréquents sont les métaux, en particulier le néthal qui existe dans les pièces de monnaie. Sur le plan physiopathologique, l'eczéma de contact est une réaction d'épaisses sensibilités à médiation cellulaire de type 4 et passe par deux phases.

Une phase d'induction ou de sensibilisation qui se déroule en 5 à 7 jours, suivie d'une phase de révélation, ce qui survient lors de la réintroduction inférieure de l'allergène qui se manifeste en 24 à 48 heures. Les allergènes en cause sont souvent les métaux comme les chromates qui existent dans le ciment, le cuir et le nickel dans les bijoux, les topiques médicamenteux comme les conservateurs, les antiseptiques, les anesthésiques, les parfums, les corticostéromides, les sulfamides, les spharadra, mais aussi des plantes responsables de ce qu'on appelle les photoallergies allergènes ou phéto ou photoallergènes. Sur le plan diagnostique clinique, un eczéma de contact peut se présenter sous forme d'un eczéma aigu avec ses phases arrêtemateuse, déséqueuse, sointante, ou sous forme d'un eczéma chronique avec sa phase de léquinification ou de l'eczéma kératose.

L'eczéma de contact se développe sur les territoires cutanés en contact direct avec l'allergène, qui peut se traduire dans une zone de contact avec une menthe, par exemple pour un eczéma du nickel d'une menthe au niveau des paupières suite à l'application d'un produit cosmétique. Donc, il faut toujours demander au patient ce qu'il a appliqué, ce qu'il a mis, ce qu'il a touché pour savoir la cause de l'eczéma de contact. Sur le plan distribution topographique, l'eczéma peut prendre un

aspect très onémateur sur le visage, en particulier sur les paupières et sur les organes génitaux externes.

Sur les pommes et les plantes où la couche cornée est beaucoup plus épaisse, la rupture du vésicule est plus difficile et l'eczéma aiguë se présente sous forme de vésicule prurigineuse, dure, enchâssée, ce qui donne l'aspect d'une déshydratation. Ça, c'est l'aspect déshydratant. D'autres causes de déshydratations sont possibles.

On peut avoir aussi un eczéma photoallergique au niveau de la localisation élective aux régions découvertes, au niveau du dos, des décolletés, du cou, de l'avant-bras et au niveau des deux mains, c'est-à-dire les endroits exposés au rayonnement solaire. La première étape du diagnostic positif est savoir reconnaître l'eczéma avec ces aspects cliniques qu'on vient de voir, soit à la face aiguë, soit en forme chronique. Le siège initial des lésions doit être subjectif d'un facteur déclenchant.

La survenue 5 à 7 jours après le premier contact avec l'allergène. Ultérieurement, le contact avec l'allergène entraîne l'apparition des lésions en 24 à 48 heures. Et puis, il faut faire une enquête allergologique.

D'abord, un interrogatoire minutieux. Les tests épicutanés sont indispensables pour le diagnostic de certitude de l'allergène en cause. Le premier diagnostic différentiel avec un eczéma de contact, c'est surtout la dermatite d'irritation.

Il est fréquent sur les mains. Il est secondaire à des agressions physiques ou chimiques directes qui ne nécessitent pas l'intervention de mécanismes immunologiques spécifiques d'un allergène. Les principaux éléments de diagnostic différentiel entre l'eczéma de contact et dermatite d'irritation sont donnés sur ce tableau.

D'abord, le délai d'apparition qui demande pour l'eczéma de contact de 5 à 7 jours pour le premier contact et pour le deuxième contact, 1 à 12 jours, alors que la dermatite d'irritation, il est très précoce, quelques heures. Le courant est plus important dans l'eczéma de contact que dans la dermatite d'irritation. Les sensations de brûlure sont plus importantes dans la dermatite d'irritation que dans l'eczéma de contact.

Les limites des lésions sont souvent étendues au-delà de la zone de contact. Les limites sont imprécises alors que la dermatite d'irritation, il est limité dans la zone de contact avec le produit irritant. L'évolution est aiguë chronique pour l'eczéma de contact alors que la dermatite d'irritation, les lésions vont devenir sèches, décubales ou intenses.

Les patch tests sont positifs dans l'eczéma de contact et négativement dans la dermatite d'irritation parce qu'il n'y a pas de sensibilisation préalable. Et sur le plan histologique, c'est une dermatite fongiforme alors que dans la dermatite d'irritation, il y a une altération caustique ou toxique de l'épiderme. Un autre diagnostic différentiel est celui de la dyshidrose des mains.

La dyshidrose palmo-plantaire, c'est une dermatose aussi fréquente, caractérisée par des vésicules dures et enchâssées, très ultrarégineuses des faces latérales des doigts et des orteils. Les poussées sont souvent estivales. Il est en général idiopathique, mais peut relever d'une sensibilisation de contact ou d'une manifestation de la dermatite atopique.

On peut penser à une galéxie matisée, des toxydermies, de la pymphibouïde bulleuse, des dermatites percutiformes, si les lésions bulleuses généralisées sont régineuses. Selon les formes d'atteintes comme celles du visage, il faut bien sûr faire discuter les autres codes d'odème du visage comme l'érysipelle, le placard inflammatoire est bien limité, le plus souvent unilatéral, parfois recouvert de vésicules dures, très sans fièvre et par l'ococytose. On peut penser aussi à un enjeu d'odème, d'odème de pique, mais c'est un odème qui est pâle, indolore, sans fèvre ni fièvre, et peut être accompagné de troubles de digestion ou atteintes respiratoires bioptiquaires.

Un eczéma de contact s'y a différencié d'un zona. Le diagnostic repose sur la présence de douleurs, la présence de vésicules hémorragiques, et propose des topographies unilatérales, segmentaires et métamériques. La meilleure mesure pour éviter la reprise de l'eczéma, c'est l'éviction de l'allergène, qui est souvent suivie de la guérison de l'eczéma.

En l'absence d'éviction, les lésions passent à la chronicité avec des lésions liquidifiées, une peau épaisse et fissuraire. On peut avoir aussi des surinfections itératives, des lésions électrodermiques, donc une exagération de l'eczéma aiguë qui devient étendue à toute la peau, et bien sûr un retentissement socioprofessionnel, surtout pour les patients qui ont un eczéma au niveau des mains. La prise en charge d'un eczéma de contact se base essentiellement sur l'éviction de l'allergène.

L'éviction de l'allergène est indispensable à la guérison car il n'y a pas de possibilité de désensibilisation dans l'eczéma propre. L'évacuité de certains allergènes rend leur éviction difficile et explique la chronicité de certains eczémas de contact. Il est important d'informer les patients sensibilisés et de leur remettre des listes de produits à éviter lorsque l'éviction de l'allergène est impossible.

Une protection vestimentaire peut être nécessaire pour éviter le contact contre des gants, des manchelons, des chaussures. Les eczémas de cause professionnelle justifient un arrêt de travail, la réalisation de tests épipytaniques et peuvent conduire à une déclaration en maladie professionnelle indémisable. Deuxième volet de la prise en charge, c'est surtout la psychothérapie locale qui est un traitement symptomatique.

Elle repose sur l'application de dermocorticoïdes de niveau d'activité très forte, forte à très forte, pendant une à deux semaines. Une corticothérapie générale est rarement utile en cas de poussée sur aiguë et au haut d'atteinte diffuse. On peut être amené à prescrire 15 à 30 mg par jour pendant 3 à 7 jours, puis dégraissant.

Une allergie de contact à une classe chimique de corticoïdes lococontraindique. La prescription de corticoïdes de la même classe se forme de topics, mais aussi parfois systémiques, car ceux-ci exposent à la survenue du toxidermie, parfois sévère. Il faut noter que les antihistamines non-sédatifs sont inutiles.

Les antihistamines non-sédatifs ou les sébastiques, de façon générale, peuvent aider à calmer le COVID. En cas d'impétigisation, une antibiothérapie générale active sur les bactéries de rangs positifs, comme l'amoxicilline protégée, est nécessaire sans retarder le traitement par corticoïdes topiques. Il faut éviter les antihistamines et les antibiotiques locaux dans ce contexte d'eczéma loconte.

Une application trop prolongée de corticoïdes peut conduire à des effets secondaires si on dépasse le délai, la quantité ou la classe qu'il faut. On peut avoir de l'atrophie cutanée, on peut avoir des dermatoséphormes au niveau du visage, de l'acné induit, de l'alermitte périore, l'épopigmentation, l'hépertricrose, on peut avoir des pleurs pleurales qui montrent la fragilité vasculaire. On peut avoir des phénomènes de rebond à l'arrêt du traitement, c'est-à-dire reprise depuis le baisse de l'eczéma après un arrêt intempestif de la corticothérapie locale.

On peut avoir des manifestations oculaires si on applique trop près de l'œil, chose à éviter. Les comptes indiqués de mettre les corticoïdes sur les paupières. On peut avoir des eczémas de contact dû au hermocorticoïde eux-mêmes et on peut avoir des passages systémiques si on applique trop de tubes, une classe très forte chez une population, par exemple, pédiatrique, il y a risque d'ostéoporose, risque d'hypercorticisme et risque d'insuffisance sérénalienne à l'arrêt.

Ce tableau présente les différentes classes d'hermocorticoïdes selon leur activité, une activité faible, modérée, forte et très forte et les présentations disponibles, soit ce formeux crème, l'épopophile ou l'héderophile au commun. Nous arrivons à la deuxième cause des eczémas. On a vu l'eczéma de contact.

Maintenant, nous allons voir la dermatite atopique. La prévalence de la dermatite atopique est en augmentation constante en Europe et en Europe aussi. La dermatite atopique est un des composants de la maladie atopique avec la conjonctivite allergique, l'arynite allergique et l'asthme.

Le prurit est un symptôme clé de la dermatite atopique et l'entretien et les lésions. La tèche cascutanée ou appelée aussi xérose est également un élément majeur de la dermatite atopique. Entre 15 et 30 % des patients ont une mutation hétérosybote, ce qu'on appelle la perte de fonction pour le gène de la filagrine, protéine synthétisée par les kératinocytes des couches supérieures de l'épiderme.

Elle participe à l'hydratation cutanée, qui est un facteur naturel d'hydratation. Les mutations bialéliques des gènes de la filagrine entraînent une absence totale d'expression qui pose les

causes du gène. La topographie caractéristique des lésions de dermatite atopique varie avec l'âge.

On va avoir des atteintes sur les convexités chez le nourissant et sur les plis d'inflexion des membres chez l'enfant plus âgé et chez l'adulte. Toute aggravation brutale des lésions cutanées de la dermatite atopique doit faire évoquer une infection à *Staphylococcus aureus*. Les corticostéroïdes topiques sont un outil de traitement de référence dans la dermatite atopique.

Il faut noter que l'atopie est l'ensemble des manifestations dues à une prédisposition génétique du système immunitaire à produire des anticorps EGE lors de l'exposition à certains antigènes protéiques comme les bacariens, les poils ou la salive des animaux, le pollen et des animaux. Les manifestations cliniques sont souvent multiples. La dermatite atopique en est une.

Mais il y a la rhinite allergique, les conjonctivites et l'asthme. L'atopie est une prédisposition personnelle et familiale d'origine génétique à produire des anticorps d'isotypes EGE lors d'expositions à des allergènes environnementaux comme les bacariens, les poils ou la salive des animaux, le pollen, les animaux. Différents organes ciblés peuvent être simultanément ou successivement atteints chez un individu ou dans une famille.

On peut avoir la peau, la rhinite et la dermatite atopique. On peut avoir l'asthme, la rhinite et l'eczéma. La rhinite ou la rhinoconjonctivite allergique, selon la mycose ORL et l'ophtalmologie.

Et puis on peut avoir des allergies alimentaires suite à une atteinte de la mycose digestive. L'eczéma atopique est différent des autres formes d'eczéma, en particulier de l'eczéma de contact, qui peut survenir en dehors de tout terrain atopique par sensibilisation à un allergène de contact avec la peau. Sur le plan physiopathologique, la dermatite atopique correspond au développement d'une réponse immunitaire qui résulte de l'interaction entre des facteurs environnementaux et inflammatoires et un terrain génétique prédisposant lié en particulier à des anomalies de la barrière cutanée.

Ces facteurs génétiques sont présents dans 50 à 70 % des patients atteints de la dermatite atopique et qui ont un parent du premier degré qui présente des signes de dermatite atopique ou un asthme ou une rhinite allergique. Les facteurs environnementaux sont plus maintenant en exergue puisqu'il y a une tendance à l'urbanisation et les mécanismes immunologiques sont souvent l'hypersensibilité retardée type 4. Il peut y avoir d'autres anomalies associées comme l'anomalie de la teneur en haut, anomalies des fonctions des glandes sébacées et carences en acides gras essentiels. La dermatite atopique, c'est une maladie qui se voit le plus souvent chez la population pédiatrique avec un âge de début qui est peut-être inférieur à l'âge de 6 mois dans 60 à 70 %, mais aussi peut-être plus précoce dans 30 à 40 % des cas.

Avant l'âge de 2 ans, la maladie a une distribution particulière et se manifeste uniquement par un eczéma aigu avec l'érythème, les vésicules, Les atteintes sont distribuées au niveau des zones

convexes, notamment le front et les joues. Sur l'extrémité céphalique avec respect de la zone médiopatale, on peut avoir une atteinte du cuir chevelu avec des lésions trouteuses. Et sur les faces d'extension des membres, sur les avant-bras et les jambes, ce sont les zones sèches du corps.

Il peut y avoir aussi une atteinte de la région pérennio-fessière, souvent chez les nourrissons aggravés par la macération des couches. Il peut y avoir une atteinte du pouce ou des fissures rétro-auriculaires. Là, ce que vous voyez sur ces trois photos, ces trois nourrissons présentent de la dermatite atopique.

On voit le soignement, l'érythème et les lésions de grattage sont distribuées sur les joues, sur le front, sur l'abdomen. On peut voir sur cette photo l'enfant qui se gratte au moment de l'examen. C'est vraiment astreignant et ce sont des lésions qui vont gêner et altérer la qualité de vie de l'enfant et de ses parents.

Comme vous voyez sur la photo en haut et à gauche, on a une dermatite atopique du front avec une surinfection herpétique. On voit l'aspect polycyclique des lésions et l'aspect embryoliqué de certaines visicules. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Kapovit-Julisberg.

Ce traitement par antiviraux d'évolution était remarquable avec une disparition des lésions sur la photo en bas. On a des lésions d'exérose cutanée, comme vous le voyez, avec des fissures et de l'érythème et des visicules en faveur d'une dermatite atopique. Chez l'enfant plus grand, la distribution des lésions va être variable.

On peut avoir une atteinte du pli, surtout au niveau du pli du coude et au niveau de la face postérieure du genou. On peut avoir des atteintes et on peut avoir de l'acrylique sèche, fissuraire, des lésions plus localisées sur les mains et sur les pieds. Là, c'est l'enfant plus grand.

Là, vous voyez des lésions de grattage. Ça témoigne de la férocité de l'exérose cutanée et vous voyez une atteinte de la face postérieure du genou. Là, après l'âge de 2 ans, l'eczéma est souvent chronique avec des lésions léquinifiées, fissuraires, une hyperkeratose et l'atteinte du pli est souvent majoritaire au niveau des mains, au niveau des chevilles, au niveau des mamelons.

Chez l'adolescent et l'adulte, on a tendance à la léquinification avec des atteintes fréquentes du visage, paupières et du cou. On peut avoir des signes associés mineurs comme l'exérose cutanée et des lésions qui rappellent l'ectiose vulgaire. D'autres signes mineurs recherchés, bien sûr, comme l'exérose cutanée, l'aspect rappelant l'ectiose vulgaire, on peut avoir la keratopilaire.

Ce sont des lésions hyperkeratosiques, ce sont des papules keratosiques centrées par un poil, souvent localisées au niveau des bras, au niveau des cuisses, mais aussi au niveau des jambes. On peut avoir des exhumatismes. Ce sont des lésions qui sont souvent achromiques, mal limitées et des fois même hypochromiques, achromiques, qui font amener les patients à consulter de crainte d'un vitiligo et qui sont secondaires à l'exérose cutanée.

On peut avoir une hyperlinéarité palmaire ou palmochromataire due à l'exérose. On peut avoir des signes oculaires, le signe de Denis Morgan. C'est comme un deuxième pli de la paupière inférieure qui signifie aussi l'exérose.

La pigmentation périorbitaire aussi. On peut avoir le dermographisme blanc. C'est dû à l'exérose cutanée.

La langue strotale, c'est une langue qui est épicée et fissuraire. On peut avoir aussi de la palmeur faciale qui signe l'exérose. Et toutes ces manifestations sont à rechercher, bien sûr, et associées à un contexte de lésions d'eczéma.

Ça fait aider à retenir le diagnostic d'une dermatitotopie. Le diagnostic positif est essentiellement anamnestique et clinique. L'anamnèse fait retenir un frêrit chronique évoluant depuis plus de 6 mois.

C'est clinique devant la distribution des lésions selon l'âge des enfants. S'il y a un enfant âgé de moins de 2 ans avec des lésions d'eczéma aiguës sur les joues, sur les zones convexes et sur le tronc, et s'il y a un grand enfant au-delà de 2 ans, s'il y a des atteintes qui rappellent l'eczéma chronique et ils ont une distribution sur le tronc, sur les mains, sur les plis, ça nous fait aider à retenir le diagnostic. Il faut noter pourquoi l'eczéma paraclinique n'est nécessaire au diagnostic.

Si on fait une numération, on peut trouver une iosinophilie et aussi si on fait le dosage des EGE, on peut trouver une élévation qui sont fréquemment observées. Là, c'est un schéma qui montre les zones de prédilection de la dermatitotopie. À droite, on a les localisations de l'eczéma chez les enfants de plus de 2 ans.

Les lésions sont plus souvent localisées au-delà du cou, de propoplite, le cou et les fissures so-auriculaires qui sont souvent très fréquentes. Dans certains zones qu'on appelle bastions, les mains et les poignets, les chevilles, les mains blancs, où ils persistent de façon chronique et parfois isolée. Le caractère chronique de ces lésions et du grattage est responsable de la lignification et des exfoliations.

On peut avoir des poussées saisonnières qui se produisent avec de plus souvent une aggravation en automne-hiver et une amélioration souvent dans les périodes estivales. On peut avoir au niveau du visage des lésions hypopigmentées, parfois rosées, filmantes, poireuses, qu'on appelle eczématides, odactes, acromiantes ou aussi pétériasis alba. Et peut-être plus diffus si les gens, là où l'ADA est la plus active, elles restent toujours et sont souvent attribuées à tort aux dermocorticoïdes.

L'axérose cutanée est quasi constante, mieux marquée en hiver. Les diagnostics différentiels de la dermatite atopique chez le nourissant, il faut éliminer d'autres dermatoses parfois exzématiformes, comme la dermite ciborique ou le psoriasis du nourissant ou la gale. Le diagnostic généralement clinique, vu que la cutanée n'est en pratique jamais nécessaire.

Sur le plan évolutif, la dermatite atopique est une dermatose chronique qui évolue partout et s'est entrecoupée de phases de rémission. On va voir la disparition des lésions à l'âge de 2 ans dans 50 % des cas, mais dans 30 % des cas, les lésions persistent à l'âge adulte, avec risque d'atteinte respiratoire, anasme ou une rhinite allergique vers l'adolescence. Quelles sont les complications agrégées en cas d'un patient ou d'un enfant qui a une dermatite atopique? Ce sont les complications les plus fréquentes, c'est d'origine infectieuse, les surinfections bactériennes, la commutation par le staph et le corps doré caractéristique de la peau de l'enfant atopique.

Il faut, bien sûr, que l'intérieur bactériologique est cutané isolant, un staph doré n'a pas de valeur diagnostique. La surinfection est difficile à apprécier dans les formes aiguës et sudatives. La présence de lésions cocteuses, jaunâtres ou pérulentes doit faire évoquer le diagnostic pour démarrer une antibiothérapie.

La surinfection virale se voit aussi due à l'herpès simplex virustique 1 qui peut surinfecter des lésions de dermatite atopique et prendre un aspect expansif. La forme la plus grave est le syndrome de Kaposi-Julister avec une surinfection herpétique qui doit être évoquée devant une modification rapide des lésions de dermatite atopique avec présence de lésculopustules, ambulaties déprimées. En leur centre, une fièvre ou une atterration de l'état général.

Et il faut, quand on a une suspicion de surinfection physique, on doit hospitaliser le patient pour démarrer un traitement antiviral et rechercher une atteinte oculaire pulmonaire neurologique qui témoigne d'une forme 1. Ces complications seront la plus fréquente dans les formes sévères de dermatite atopique justifiées de rechercher par l'interrogatoire l'annonce d'herpès recurrent dans la famille ou dans l'entourage des enfants atteints de D.A. et de prévenir les parents du risque potentiel. On peut avoir aussi, dans l'évolution du dermatite atopique, un risque ou une complication par un eczéma de contact. Il faut l'évoquer chez les patients qui répondent mal au traitement habituel et incité à une attitude de prévention limitant l'utilisation d'autopie potentiellement à risque pour développer des eczémas de contact.

Le retard de croissance scélère n'est peut-être observé en cas de dermatite atopique grave. Il se corrige habituellement quand la dermatite atopique est traitée efficacement. Elle doit faire rechercher une allergie alimentaire.

Dans le cadre d'une infection chronique de l'enfant, la surveillance de la croissance est indispensable. Les complications phthalmologiques sont rares à ce point de keratoconjunctivite au cataracte. Elles compliquent les dermatites atopiques sévères d'évolution prolongée et ne sont pas à rechercher systématiquement.

La dermatite atopique est une dermatose chronique, astringente, qui va grandir avec l'enfant et accompagner souvent d'une astérisation importante de la qualité de vie de l'enfant et de ses parents. Donc la prise en charge essentielle va lutter contre l'inflammation par des dermocorticoïdes, mais aussi il y a d'autres immunosuppresseurs qui ont la même tâche comme

le tacrolimus, pimicrolimus et l'ascomycine. Ces trois derniers n'existent pas sur le marché marocain, on n'a que les dermocorticoïdes, mais les patients pourront les ramener de France ou de l'Espagne.

Deuxième élément, c'est lutter contre l'infection. On peut utiliser des antiseptiques, de l'antibiothérapie générale en cas de signe de surinfection, mais en dehors de ce contexte-là, il n'est pas judicieux d'utiliser des antiseptiques ou de l'antibiothérapie locale générale pour lutter d'abord contre la zéro scrutanée, comme on parle d'une hygiène corporelle utilisant des savons, ce qu'on appelle les pains sur gras et des émollients. C'est des crèmes qui vont apporter à la peau ce qui lui manquait de façon sur le plan hydratation.

Donc, c'est deux crèmes appliquées deux fois par jour d'une façon régulière et par une quantité importante. Il faut lutter contre le COVID. On peut utiliser juste les antihistamines pour calmer les sensations de pleurisme et pour noter que l'histamine ne fait pas partie des médiateurs de la dermatite atopique, mais de l'eczéma de contact.

À côté des traitements qu'on prescrit, il y a les mesures d'hygiène de vie. Il faut éviter les fibres synthétiques, il faut éviter de surhabiller l'enfant. Ce sont des enfants qui ont une intolérance naturelle à la chaleur, parce que dès qu'ils transpirent, la peau s'irrite.

Il faut éviter l'exposition au tabac, il faut maintenir une température fraîche dans la chambre et il faut faire attention à l'herpès, éviter le contact avec les personnes atteintes et éviter d'embrasser l'enfant, c'est indépendant de l'herpès labial. Il faut bien sûr assurer une vaccination correcte et normale sur les personnes atteintes. Lutter contre les acariens par l'aération des chambres, du poussierage, éviter de les taper les moquettes, éviter les animaux à courir et bien sûr encourager l'allaitement maternel.

À côté de l'eczéma de contact et de la dermatitotopie, on peut avoir de l'eczéma numulaire qui va se manifester par des plaques erythématospameuses, périgineuses, rondes ou ovalaires de un centimètre à plusieurs centimètres, nombreuses, qui rappellent la pièce de monnaie. Ils sont habituellement sur les membres inférieurs et supérieurs. Lithiologie, on peut avoir de la dermatitotopie, on peut avoir de l'eczéma de contact, on peut avoir des foyers infectieux.

Deuxième eczéma, après l'eczéma numulaire, on a l'eczéma dyshidrosique qui va se manifester par des vésicules enchâssées dans l'épiderme avec un fluoride, surtout au niveau palmofrancaire, sur les faces latérales des doigts et des orteils. Lithiologie, soit un eczéma de contact, soit dans le cadre d'une dermatitotopie, soit un foyer infectieux, de frangie ou d'origine idiopathique. Encore une autre forme de l'eczéma, c'est l'eczéma d'ostase qui se voit chez les patients qui souffrent d'une insuffisance veineuse et se manifestent par des plaques erythématospoïneuses sointantes, d'abord sur le tragi- varicoe, puis extension secondaire.

Il y a aussi l'eczéma craquelée qui se voit chez le sujet âgé et se voit sur les faces d'extension des membres, sur le tronc, qui va se manifester par des plaques erythématospoïneuses très

sèches. Au final, c'était pour vous dire que l'eczéma est un syndrome avec des étiologies multiples. Les principales causes sont l'eczéma de contact et la dermatitose qu'il faut bien sûr savoir diagnostiquer et savoir prendre en charge.

Je vous remercie pour votre attention.